



LIVEBOOK

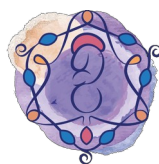
A Reforma Obstétrica no Brasil

Por que precisamos transformar o modelo de atenção ao parto e nascimento

Palestrante

Luciane da Silva D'Avila

Enfermeira Obstétrica • Presidente da ABENFO Nacional



Siaparto

São Paulo / SP • 2025

Como ler este Livebook

Este Livebook foi feito para você que está começando a estudar o tema. A linguagem é direta, os termos técnicos são explicados antes de aparecerem, e há vários elementos visuais para ajudar na sua leitura. Veja o que esperar:

- **Glossário Antecipado:** logo no início, traz os termos-chave da palestra com definições rápidas. Volte aqui sempre que precisar.
- **Linha do Tempo:** mostra os marcos históricos do tema, para você entender de onde tudo vem.
- **Boxes "Você sabia?":** curiosidades e dados que ampliam seu repertório.
- **Boxes "Para aprofundar":** sugestões opcionais para quem quer ir além.
- **Mapa de Conexões:** mostra como este tema se conecta a outras disciplinas que você está vendo na faculdade.
- **Recapitulação Visual:** um mapa mental para consolidar tudo no final.

Antes de começar — uma palavra sobre o tema

Este Livebook trata de saúde materna no Brasil. Você verá dados sobre cesarianas, mortalidade materna, violência obstétrica e acesso desigual ao cuidado. São temas duros, mas necessários: entendê-los é o primeiro passo para qualquer profissional que queira atuar nessa área. A palestra que você vai estudar não traz só o problema — traz caminhos concretos de transformação.

Glossário Antecipado

Antes de mergulhar no conteúdo, conheça os termos que vão aparecer ao longo do Livebook. Esta lista funciona como sua "caixa de ferramentas" — volte aqui sempre que precisar.

Termo	O que significa, em poucas palavras
Reforma Obstétrica	Proposta de transformação profunda do modelo de atenção ao parto e nascimento no Brasil, mudando quem coordena o cuidado e como ele é prestado.
Enfermeira Obstétrica	Enfermeira com pós-graduação (especialização) em obstetrícia. Habilitada legalmente a assistir gestantes em pré-natal, parto de risco habitual e pós-parto.
Obstetiz	Profissional formada em curso de graduação específico de Obstetrícia (não é enfermagem). Atua exclusivamente na saúde da mulher, gestante, parto e recém-nascido.
ABENFO	Associação Brasileira de Obstetizes e Enfermeiros Obstetras. Entidade nacional fundada em 1992 que representa a categoria profissional.
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem. Órgão que regula o exercício da enfermagem no Brasil.
SUS	Sistema Único de Saúde. Política pública brasileira que garante atendimento gratuito e universal à saúde, criada pela Constituição de 1988.
Mortalidade Materna	Mortes de mulheres durante a gestação, no parto ou até 42 dias após o parto, por causas relacionadas à gravidez. Indicador-chave de saúde pública.
Mortalidade Neonatal	Mortes de bebês nos primeiros 28 dias de vida.
Cesariana	Parto cirúrgico realizado por incisão no abdome. É indicada em situações específicas, mas no Brasil é feita em excesso.
Modelo Hospitalocêntrico	Modelo de saúde em que o hospital é o centro do cuidado, e não a comunidade ou a atenção primária.
Modelo Médico-centrado	Modelo em que o médico é o protagonista absoluto do cuidado, com pouca participação de outros profissionais e da própria mulher.
Centro de Parto Normal (CPN)	Estabelecimento de saúde dedicado ao parto de risco habitual, conduzido por enfermeiras obstétricas e obstetizes, com ambiente acolhedor e menos intervenções.
Boas Práticas no Parto	Conjunto de recomendações da OMS baseadas em evidências, como

Termo	O que significa, em poucas palavras
	liberdade de movimento, presença de acompanhante, contato pele a pele e amamentação na primeira hora.
Violência Obstétrica	Conjunto de práticas desrespeitosas, abusivas ou desnecessárias durante o parto que violam direitos da mulher (físicos, emocionais ou sexuais).
Rede Cegonha	Política pública criada em 2011 para qualificar a atenção materno-infantil no SUS. Foi posteriormente reformulada como Rede Alyne.
Rede Alyne	Reedição da Rede Cegonha lançada em 2024, em homenagem a Alyne Pimentel, mulher negra cuja morte materna gerou condenação internacional do Brasil.
Atenção Primária à Saúde (APS)	Primeiro nível de cuidado no SUS — UBS, ESF. Porta de entrada do sistema.
Risco Habitual	Classificação de gestações sem complicações graves, que correspondem a cerca de 85% dos partos segundo a OMS.
Modelo Biopsicossocial	Abordagem que considera o cuidado em saúde levando em conta dimensões biológicas, psicológicas e sociais — não só a doença.

Dica de leitura

Você não precisa decorar tudo agora. O glossário existe justamente para você consultar enquanto lê. Volte aqui sempre que encontrar um termo que não lembre.

Resumo Executivo

A palestra de Luciane da Silva D'Avila, Presidente da ABENFO Nacional, apresenta uma proposta urgente: a Reforma Obstétrica no Brasil. A tese central é que o modelo brasileiro de atenção ao parto está em crise — somos vice-campeões mundiais de cesariana, com taxas em torno de 59%, e ainda registramos índices alarmantes de mortalidade materna e neonatal, especialmente entre mulheres negras.

A palestrante explica que reformas estruturais já aconteceram no país — como a Reforma Psiquiátrica — e que precisamos do mesmo tipo de transformação na obstetrícia. Iniciativas anteriores, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a Rede Cegonha e a recente Rede Alyne, trouxeram avanços importantes, mas não conseguiram mudar os indicadores principais. O motivo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é claro: para mudar resultados, é preciso mudar quem lidera o cuidado.

A proposta da Reforma Obstétrica é colocar enfermeiras obstétricas e obstetrizes na liderança da atenção ao parto de risco habitual, em colaboração com médicos, doulas, fisioterapeutas e psicólogos. Países como Nova Zelândia, Senegal e Uganda já fazem isso com bons resultados. A OMS estima que essa mudança poderia salvar até 4,3 milhões de vidas por ano no mundo. No Brasil, o caminho passa por um manifesto entregue ao Ministério da Saúde, articulações com o Conselho Federal de Enfermagem e mobilização da categoria.

Sobre a Palestrante

Luciane da Silva D'Avila é enfermeira obstétrica e Presidente da ABENFO Nacional (Associação Brasileira de Obstetizes e Enfermeiros Obstetras). Atuante no estado de Santa Catarina, integra a Comissão de Parto Domiciliar Planejado da ABENFO-SC e tem trajetória sólida na defesa de políticas públicas de saúde da mulher. Recentemente, participou ativamente das oficinas do Ministério da Saúde sobre o Implanon — método contraceptivo subdérmico que está sendo expandido no SUS — defendendo que a inserção do dispositivo seja realizada também por enfermeiras capacitadas, com base em evidências e respeito às escolhas das usuárias.

Por que ela é uma referência neste tema:

Como Presidente da entidade que representa nacionalmente as enfermeiras obstétricas e obstetizes, Luciane está na linha de frente da articulação política da Reforma Obstétrica — incluindo a entrega do Manifesto pela Reforma Obstétrica ao Ministério da Saúde em 2025 e a interlocução com o Conselho Nacional de Saúde e o Congresso Nacional.

Para conhecer mais

- **ABENFO Nacional:** abenfo.org.br
- **ABENFO Santa Catarina:** abenfosantacatarina.com.br

Linha do Tempo do Tema

Para entender a Reforma Obstétrica, é importante conhecer os marcos que a antecederam. Esta linha do tempo mostra os principais eventos da história da enfermagem obstétrica e da saúde materna no Brasil.

Ano	Marco
1954	Fundação da Associação Brasileira de Obstetristas (ABO), origem histórica da ABENFO.
1988	Constituição Federal cria o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo saúde universal.
1992	Fundação oficial da ABENFO — Associação Brasileira de Obstetristas e Enfermeiros Obstetras.
2004	Lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), primeira política específica para saúde sexual e reprodutiva.
2011	Criação da Rede Cegonha — primeira política nacional que reconhece formalmente o protagonismo das enfermeiras obstétricas e cria os Centros de Parto Normal.
2014	Pesquisa "Nascer no Brasil" (Fiocruz) revela publicamente os índices de violência obstétrica e excesso de cesarianas no país.
2024	OMS lança o "Modelo de Transição Obstétrica" e o tema "Inícios Saudáveis, Futuros Esperançosos" como diretriz mundial.
2024	Brasil relança a Rede Cegonha como Rede Alyne, em homenagem a Alyne Pimentel.
2025	Manifesto pela Reforma Obstétrica é entregue ao Ministério da Saúde. Audiência pública no Congresso Nacional. ABENFO articula formação de 750 novas enfermeiras obstétricas.

Você sabia?

Alyne Pimentel foi uma jovem mulher negra brasileira que morreu em 2002 por complicações obstétricas evitáveis. Em 2011, o Brasil foi condenado pela ONU no caso "Alyne v. Brasil" — primeira vez que um país foi responsabilizado internacionalmente por morte materna. A Rede Alyne carrega esse nome como compromisso de não repetir a história.

Tópico 1 — O que é a Reforma Obstétrica?

? Você já se perguntou...

...por que tantas mulheres no Brasil saem de uma sala de parto traumatizadas, mesmo sem ter tido nenhuma complicação grave? E por que isso parece tão "normal" no nosso país, mas não em vários outros?

Em poucas palavras

A Reforma Obstétrica é uma proposta de mudança profunda no modelo de atenção ao parto e nascimento no Brasil — semelhante ao que aconteceu na Reforma Psiquiátrica nas décadas de 1980 e 1990. A ideia central é mudar quem lidera o cuidado: passar do modelo médico-centrado e hospitalocêntrico para um modelo onde enfermeiras obstétricas e obstetrizes coordenam o cuidado de partos de risco habitual, com colaboração de outros profissionais.

O que é, na prática

Pense numa analogia simples: imagine que, num restaurante, todos os pratos — do mais simples ao mais complexo — fossem preparados por um chef especializado em alta gastronomia. Ele faria tudo com qualidade, mas seria caro, demorado, e muitas vezes excessivo para um prato simples. O mais eficiente é deixar o chef cuidar dos pratos complexos, enquanto cozinheiros qualificados cuidam dos pratos do dia a dia.

Na obstetrícia acontece algo parecido. O parto é, na maior parte das vezes (cerca de 85% dos casos, segundo a OMS), um processo fisiológico saudável — não uma doença. Atribuir todo parto à supervisão exclusiva de médicos obstetras gera duas distorções: medicalização excessiva (intervenções desnecessárias, como cesarianas eletivas) e desperdício de profissionais altamente especializados em casos que não exigem essa expertise. A Reforma Obstétrica propõe que enfermeiras obstétricas e obstetrizes — profissionais formadas justamente para o parto fisiológico — assumam essa coordenação, deixando os médicos para os casos de complicação real.

De onde vem essa ideia?

A inspiração mais direta é a Reforma Psiquiátrica brasileira, conduzida principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Antes dela, o modelo psiquiátrico brasileiro era baseado em grandes hospitais psiquiátricos (manicômios), com internações longas e práticas frequentemente violentas. A reforma transformou isso num modelo baseado em CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), atenção comunitária e respeito aos direitos humanos. A Reforma Obstétrica propõe um movimento equivalente: tirar o parto do centro do hospital e devolver à mulher a centralidade do seu cuidado, com profissionais adequados a cada situação.

Internacionalmente, a referência vem da OMS e da UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas), que desde 2014 publicam diretrizes sobre o papel central das enfermeiras obstétricas. Em 2024, a OMS lançou o "Modelo de Transição Obstétrica", documento que propõe princípios e modelos práticos para essa mudança em diferentes países.

Por que isso importa para você?

Se você está estudando enfermagem, obstetrícia, medicina, saúde coletiva, psicologia, serviço social ou qualquer área da saúde — esse tema vai impactar diretamente a sua carreira. Você vai trabalhar num sistema em transição. Entender essa transição agora significa estar preparada(o) para liderá-la, e não para ser pega(o) por ela.

Pontos-chave

- A Reforma Obstétrica é uma proposta de mudança estrutural do modelo brasileiro de atenção ao parto, não apenas uma reforma de procedimentos.
- Sua principal inspiração nacional é a Reforma Psiquiátrica; sua principal inspiração internacional são as diretrizes da OMS sobre liderança da enfermagem obstétrica.
- Não se trata de excluir médicos, mas de redefinir papéis: enfermeiras obstétricas e obstetrizas lideram o parto de risco habitual; médicos atuam nas complicações.
- A reforma exige mudanças simultâneas em: formação profissional, regulação, financiamento e cultura institucional.

Você sabia?

A Reforma Psiquiátrica brasileira só ganhou força após a divulgação de denúncias de violência nos manicômios — especialmente o famoso "Holocausto Brasileiro" de Barbacena (MG). De forma

análoga, a Reforma Obstétrica ganhou tração após a pesquisa "Nascer no Brasil" (Fiocruz, 2014) escancarar dados de violência obstétrica que muitos profissionais já conheciam, mas a sociedade não.



Para aprofundar

Se você quer entender a fundo a comparação com a Reforma Psiquiátrica, busque por "Lei Paulo Delgado" (Lei 10.216/2001) e pelos textos do psiquiatra italiano Franco Basaglia, principal inspiração teórica do movimento brasileiro.

Aplicação prática

Imagine que você é estagiária(o) numa Unidade Básica de Saúde (UBS) e precisa ajudar a montar um grupo educativo para gestantes do bairro. Aplicando o pensamento da Reforma Obstétrica, você não montaria apenas palestras com o médico ginecologista — incluiria a enfermeira obstétrica, abordaria temas como direitos no parto, presença de acompanhante e plano de parto. Você integraria psicologia, fisioterapia pélvica e nutrição. Esse grupo educativo, na lógica da reforma, é parte do cuidado, não um "extra".

Tópico 2 — Os Números do Problema

? Você já se perguntou...

...o que os números do parto no Brasil dizem sobre a desigualdade do nosso país?

Em poucas palavras

Os indicadores brasileiros de saúde materno-infantil são preocupantes em três frentes: cesarianas em excesso, mortalidade materna alta (especialmente entre mulheres negras) e cobertura insuficiente de cuidados básicos durante o pré-natal. Esses números não são acidentes — são resultado direto do modelo de cuidado adotado.

Os principais dados

Indicador	Dado Brasil	O que isso significa
Cesarianas	~59% dos partos	Brasil é vice-campeão mundial. A OMS recomenda no máximo 10–15%.
Cesarianas em mulheres brancas	~48%	Mais alto que a média geral.
Cesarianas em mulheres negras	~39%	Menor — mas reflete falta de acesso, não escolha.
Gestações não planejadas	~55%	Mais da metade das gestações no Brasil.
Gestações não planejadas (mulheres negras)	~74%	Reflete desigualdade de acesso a métodos contraceptivos.
Métodos contraceptivos de longa duração	~2% das mulheres	Muito abaixo dos países europeus.
Adequação total dos cuidados pré-natais	15–21%	Apenas 1 em cada 5 mulheres recebe todos os cuidados recomendados.
Adequação pré-natal em mulheres negras	~8%	Menos de 1 em cada 10 — desigualdade racial gritante.

Indicador	Dado Brasil	O que isso significa
Partos de risco habitual	~85% segundo OMS	Maioria dos partos é fisiológico. Não justifica intervenção cirúrgica em massa.

De onde vêm esses números?

Os principais dados citados pela palestrante vêm da pesquisa "Nascer no Brasil" (Fundação Oswaldo Cruz, 2014), de boletins do DATASUS, dos relatórios anuais da OMS sobre saúde materna, e do Manifesto pela Reforma Obstétrica articulado pela ABENFO Nacional em parceria com a Rede Feminista de Saúde, ReUna, Brasco, ABEM, COFEN e outras entidades.

Por que isso importa para você?

Esses dados são de prova pública. Se você está estudando saúde, eles vão aparecer em provas, em concursos, em residências, em artigos científicos e em qualquer trabalho relacionado à saúde da mulher. Mas, mais importante, eles representam pessoas — histórias reais. Uma estatística de 59% de cesarianas é uma realidade que pode ser de uma irmã, vizinha, paciente. Conhecer os números é o primeiro passo para entender a dimensão real do problema.

Pontos-chave

- A taxa brasileira de cesarianas (~59%) é cerca de 4 a 6 vezes maior que o recomendado pela OMS.
- Mulheres negras enfrentam piores indicadores em quase todos os recortes: pré-natal inadequado, gestações não planejadas, violência obstétrica.
- A adequação dos cuidados pré-natais é dramaticamente baixa — entre 15% e 21% no geral.
- A maioria dos partos (85%) é de risco habitual, não justificando intervenção cirúrgica em massa.

Você sabia?

A taxa de 59% de cesarianas significa que, em média, mais da metade dos bebês nascidos no Brasil hoje vêm ao mundo por cirurgia. Em alguns hospitais privados, essa taxa ultrapassa 85%. Para comparação: nos países nórdicos, a taxa fica em torno de 15–17%; no Reino Unido, cerca de 30%.



Para aprofundar

A pesquisa "Nascer no Brasil" tem versões resumidas disponíveis no site da Fiocruz e da ENSP. Ela é a base estatística mais citada nas discussões sobre saúde materna no país. Para um TCC ou artigo, é referência obrigatória.

Aplicação prática

Suponha que você precise apresentar um seminário sobre desigualdade racial em saúde. Os dados acima oferecem uma estrutura clara: você pode mostrar como a desigualdade racial não está só no acesso, mas também na qualidade do cuidado recebido. Os 8% de adequação pré-natal em mulheres negras vs. percentuais mais altos em mulheres brancas são um dado-síntese poderoso para começar essa discussão.

Tópico 3 — Por Que as Políticas Anteriores Não Bastaram

? Você já se perguntou...

...se o Brasil já tentou várias políticas de saúde da mulher, por que os indicadores continuam ruins?

Em poucas palavras

O Brasil teve sim avanços em políticas obstétricas — a PNAISM, a Rede Cegonha, a Rede Alyne. Cada uma trouxe ganhos pontuais, mas nenhuma conseguiu mover os indicadores principais (cesarianas e mortalidade materna) de forma significativa. A palestrante explica que isso aconteceu porque essas políticas não tocaram no ponto-chave: quem coordena o cuidado.

As políticas, em ordem cronológica

PNAISM — Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004)

Primeira política brasileira a olhar de forma ampla para a saúde sexual e reprodutiva. Trouxe um olhar integral — para além do corpo da mulher como "máquina reprodutora". Ainda é uma referência teórica, mas teve baixa execução prática.

Rede Cegonha (2011)

Foi um marco institucional. Criou os Centros de Parto Normal (CPN), reconheceu o papel das enfermeiras obstétricas e introduziu o conceito de "boas práticas no parto" no SUS. Conforme palavras da palestrante, "a Rede Cegonha só avançou porque foi abraçada pelas enfermeiras obstétricas e pelas obstetrizes". Mesmo assim, não conseguiu mudar os indicadores nacionais.

Rede de Atenção Materno-Infantil (RAME)

Mencionada brevemente pela palestrante como um "retrocesso", durante o governo anterior. Reduziu o protagonismo das enfermeiras obstétricas e voltou a centralizar o cuidado no modelo médico-hospitalar.

Rede Alyne (2024)

Reedição da Rede Cegonha. Tem objetivos ambiciosos: reduzir 25% da mortalidade materna até 2027, reduzir 50% da mortalidade entre mulheres pretas até 2027, e atingir o ODS de 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos até 2030. A palestrante demonstra ceticismo: "Posso estar sendo muito pessimista, mas quase que arrisco o meu pescoço a dizer que a gente não vai conseguir." A crítica central: a Rede Alyne ainda não coloca a enfermeira obstétrica e a obstetriz como figura central da mudança.

Por que essas políticas não bastaram?

A resposta da palestrante é direta: porque nenhuma delas alterou a estrutura central do modelo. Programas de saúde podem mudar, financiamento pode aumentar, mas se a lógica de quem coordena o cuidado permanece a mesma — médico-centrada, hospitalocêntrica — os indicadores resistem.

Pense numa analogia: é como tentar melhorar o trânsito de uma cidade construindo mais avenidas, mas sem mudar a forma como as pessoas se deslocam. Você gasta dinheiro, ganha popularidade, mas o trânsito continua. A Reforma Obstétrica argumenta que precisamos mudar a forma de "se deslocar", não só construir mais avenidas.

Pontos-chave

- Políticas brasileiras tentaram melhorar a saúde da mulher há mais de 20 anos, com avanços limitados.
- A Rede Cegonha (2011) foi o avanço mais significativo, mas não mudou indicadores principais.
- A Rede Alyne (2024) é vista com ceticismo por não colocar enfermeiras obstétricas e obstetrizes no centro.
- Sem mudar a estrutura de coordenação do cuidado, mudanças de programas não geram mudança de indicadores.

Você sabia?

Os Centros de Parto Normal (CPN) chegaram a ter financiamento federal pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas muitos municípios recusaram a verba, "porque isso muda a lógica do cuidado", segundo Luciane. Esse é um caso clássico de resistência institucional a mudanças

que, embora tecnicamente comprovadas, ameaçam o status quo.



Para aprofundar

Para entender o ecossistema de políticas materno-infantis no SUS, busque pelo livro "Saúde da Mulher no Brasil" e pelos textos da Profa. Maria do Carmo Leal (Fiocruz), uma das principais pesquisadoras da área.

Aplicação prática

Quando você se deparar, em provas ou trabalhos, com a pergunta "por que o SUS não conseguiu reduzir a mortalidade materna?", uma resposta tecnicamente sofisticada não se concentra em "falta de verba" ou "falta de profissionais", mas no modelo de organização do cuidado. Isso te diferencia.

Tópico 4 — A Proposta: Liderança da Enfermagem Obstétrica

? Você já se perguntou...

...o que muda concretamente quando uma enfermeira obstétrica lidera o cuidado, em comparação com o modelo médico-centrado?

Em poucas palavras

A proposta central da Reforma Obstétrica é colocar enfermeiras obstétricas e obstetrizes na liderança do cuidado obstétrico de risco habitual. Isso significa: elas coordenam o pré-natal, o parto e o pós-parto; trabalham em colaboração com médicos, doulas, fisioterapeutas, psicólogos; e encaminham casos de complicação para os obstetras. Não é "tirar o médico" — é redistribuir papéis com base na competência específica de cada profissional.

O que a OMS recomenda

Em 2024, a OMS lançou o "Modelo de Transição Obstétrica", trazendo princípios orientadores que servem como guia para os países. Os principais são:

- **Cuidado equitativo baseado nos direitos humanos:** considerando o desejo da mulher e sua participação ativa nas decisões.
- **Cuidado centrado na pessoa e respeitoso:** relação de confiança, parceria, escuta.
- **Assistência de alta qualidade:** baseada em evidências científicas, não em hábitos institucionais.
- **Cuidado coordenado por parteiras (enfermeiras obstétricas/obstetrizes):** em todos os ambientes — atenção primária, hospital, casa de parto, domicílio.
- **Cuidado integrado e colaborativo:** com médicos, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas e doulas atuando em equipe — mas com liderança definida.

O dado da OMS que sustenta a proposta

Estatística-chave

Mesmo um aumento modesto de apenas 10% nas intervenções realizadas por enfermeiras obstétricas e obstetrizas (com autonomia profissional plena) pode evitar:

- 23% das mortes maternas e neonatais por ano
- 14% dos natimortos por ano

E há uma projeção ainda mais expressiva: investir no acesso universal ao cuidado obstétrico de qualidade liderado por enfermeiras obstétricas e obstetrizas pode salvar até 4,3 milhões de vidas por ano no mundo até 2035.

De onde vem esse modelo?

A formação histórica das parteiras (em inglês, "midwives") como profissionais centrais do parto é mais antiga que a própria medicina obstétrica moderna. Em quase todas as culturas tradicionais, eram mulheres experientes da comunidade que assistiam os partos. A medicina obstétrica como especialidade é uma construção dos séculos XIX e XX, surgida com a hospitalização do parto. Na Europa do Norte, esse processo ocorreu de forma diferente do Brasil: as parteiras (midwives) foram profissionalizadas e integradas ao sistema de saúde, mantendo seu protagonismo. No Brasil, esse processo foi interrompido, e o parto foi quase totalmente "capturado" pela medicina hospitalar.

Por que isso importa para você?

Se você é estudante de enfermagem, está estudando para uma carreira que pode ter mais protagonismo do que ela tem hoje. Se você é estudante de medicina, está estudando para uma carreira que precisa aprender a colaborar — e não só a comandar. Se você está em outra área da saúde, está aprendendo o que significa "trabalho em equipe interdisciplinar" de verdade — não só no discurso, mas na prática.

Pontos-chave

- A liderança é sobre risco habitual (85% dos partos) — não exclui obstetras, mas redistribui papéis.
- A OMS oferece princípios e dados que sustentam essa proposta há mais de uma década.
- Um aumento modesto de 10% em intervenções por enfermeiras obstétricas pode evitar 23% das mortes maternas e neonatais.
- A formação histórica das parteiras é mais antiga que a medicina obstétrica.

Você sabia?

A palavra "obstetrícia" vem do latim "obstetrix", que significa "aquela que está ao lado". Originalmente, era exatamente o trabalho da parteira: estar ao lado da mulher durante o parto. A medicalização transformou isso em "intervir sobre", quando o sentido original é "acompanhar".

Para aprofundar

Para entender modelos colaborativos médico-enfermagem na obstetrícia, busque pelo "Modelo Colaborativo de Integração Horizontal" (proposto em 2017) e pelos artigos da revista "Reproductive Health" sobre liderança da enfermagem obstétrica.

Aplicação prática

Imagine que você está numa estágio supervisionado num centro obstétrico. Aplicar o pensamento da Reforma Obstétrica significa observar e questionar: quem decide o que? A mulher é consultada antes das intervenções? O acompanhante é respeitado? As boas práticas (presença de acompanhante, livre movimentação, contato pele a pele) estão sendo seguidas? Esse olhar crítico é o que diferencia uma estagiária(o) que apenas "executa" de uma(um) que aprende.

Tópico 5 — Modelos Internacionais como Inspiração

? Você já se perguntou...

...como países muito diferentes do Brasil — alguns mais ricos, outros mais pobres — conseguem ter indicadores melhores que os nossos?

Em poucas palavras

A OMS, no documento de 2024, apresenta cinco modelos internacionais de organização do cuidado obstétrico. A palestrante destaca que o Brasil não vai poder seguir um único modelo, mas precisará pensar em modelos regionalizados — dada a dimensão e a diversidade do país.

Os cinco modelos da OMS

1. Continuidade de cuidado — Nova Zelândia

A gestante escolhe a maternidade, a enfermeira obstétrica/obstetriz e a equipe que vai acompanhá-la durante toda a jornada (pré-natal, parto, pós-parto). Essas profissionais ficam disponíveis 24/7. As maternidades têm acordos formais de transferência com hospitais para casos de complicação. É um modelo de altíssima qualidade, mas pressupõe boa estrutura institucional e integração entre níveis de atenção.

2. Cuidado de base comunitária — Senegal

A enfermeira obstétrica é itinerante. Faz visitas regulares a unidades de saúde, locais comunitários e pontos de encontro. Garante serviços de saúde maternos, neonatais, infantis e adolescentes. Gerencia medicamentos. A própria comunidade ajuda a garantir moradia para as profissionais. A palestrante destaca a possível analogia com a Amazônia brasileira — onde profissionais precisam viajar de barco por horas para chegar a comunidades.

3. Centro de Parto Normal — modelo já presente no Brasil

Estabelecimento dedicado ao parto fisiológico, com cuidado liderado por enfermeiras obstétricas e obstetritz. Sistema robusto de encaminhamento entre unidades. O Brasil já tem alguns CPNs em funcionamento (Sofia Feldman, em Belo Horizonte, é referência), mas precisa expandir e fortalecer essa rede.

4. Prática privada — Uganda

Maternidades privadas oferecem cuidados completos (pré-natal, parto, pós-parto, recém-nascido). Têm colaboração estreita com profissionais de outras áreas. Têm acesso imediato ao planejamento familiar. E aqui o ponto interessante: muitas vezes são custeadas pelo sistema público — uma parceria público-privada bem regulada.

5. Cenários de crise humanitária

Modelo emergente, cada vez mais relevante. A palestrante cita a tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, que exigiu mobilização rápida para atender gestantes deslocadas. A proposta é criar um modelo de crise geral para o Brasil, com enfermeiras cadastradas e capacitadas, prontas para serem acionadas em emergências humanitárias. Isso pressupõe capacitação em emergência obstétrica, sensibilidade cultural e articulação com autoridades locais.

O denominador comum

Apesar das diferenças, todos esses modelos têm algo em comum — e é justamente esse "algo" que o Brasil precisa adotar:

O que une todos os modelos

Todos são coordenados por enfermeiras obstétricas e obstetritz, que tomam decisões autônomas em sua área de atuação como parte de uma equipe interdisciplinar. Quando surgem complicações, essas profissionais colaboram com obstetras, pediatras e outros especialistas por meio de consultas eficazes e sistemas de encaminhamento, garantindo um atendimento contínuo e personalizado às mulheres e aos recém-nascidos.

Pontos-chave

- Existem múltiplos modelos viáveis — não há "fórmula única" mundial.
- O Brasil deverá adotar uma abordagem regionalizada, dada sua dimensão e diversidade.
- O denominador comum dos modelos bem-sucedidos é a liderança da enfermagem obstétrica.
- A capacidade de resposta a crises humanitárias é uma necessidade crescente, dada a frequência de eventos climáticos extremos.

Você sabia?

Sofia Feldman, hospital de referência citado pela palestrante, foi um dos primeiros centros brasileiros a implementar consistentemente o modelo de liderança das enfermeiras obstétricas. Localizada em Belo Horizonte, é referência nacional e internacional, e recebe profissionais de várias partes do Brasil para estágios e capacitações.

Para aprofundar

O documento completo da OMS sobre o Modelo de Transição Obstétrica de 2024 está disponível em [who.int](https://www.who.int). É leitura técnica densa, mas tem versões resumidas (executive summaries) acessíveis. Para a Nova Zelândia, busque pelo "New Zealand College of Midwives".

Aplicação prática

Pense num bairro periférico que você conheça. Aplicando os cinco modelos: o que faria mais sentido lá? Provavelmente uma combinação — talvez um CPN próximo a um hospital de referência (modelo 3), com agentes comunitárias que façam a articulação com gestantes (inspirado no modelo 2). Esse exercício de "tradução cultural" dos modelos é um excelente conteúdo para um trabalho acadêmico ou para uma proposta concreta a uma secretaria de saúde.

Mapa de Conexões

Este tema não vive isolado. Veja como ele se conecta a outras disciplinas que você possivelmente está estudando — ou vai estudar — na sua graduação.

Disciplina	Como se conecta com a Reforma Obstétrica
Saúde Coletiva / Saúde Pública	A Reforma Obstétrica é uma proposta de política pública. Conecta com SUS, redes de atenção, planejamento em saúde e determinantes sociais.
Sociologia / Antropologia	Modelos de parto refletem visões de mundo sobre o corpo feminino. Conecta com debates sobre medicalização, gênero e cultura.
Direitos Humanos / Bioética	Violência obstétrica é tema de direitos humanos. Conecta com bioética, direitos reprodutivos e jurisprudência (caso Alynne Pimentel na ONU).
Estudos de Gênero	A obstetrícia é um campo onde gênero e poder se cruzam. Conecta com feminismo, autonomia corporal e violência institucional.
Estudos Étnico-Raciais	Os indicadores mostram desigualdade racial estrutural. Conecta com racismo institucional, saúde da população negra e interseccionalidade.
História da Medicina/Enfermagem	A reforma é uma resposta a uma trajetória histórica. Conecta com história das parteiras, hospitalização do parto e profissões em saúde.
Psicologia	Parto envolve dimensões emocionais profundas. Conecta com psicologia perinatal, vínculo mãe-bebê e trauma.
Direito	Há legislação específica (Lei do Acompanhante, Lei das Boas Práticas) e jurisprudência relevante. Conecta com direito da saúde e da mulher.
Economia da Saúde	O excesso de cesarianas tem custo bilionário. Conecta com avaliação de tecnologias, custo-efetividade e financiamento do SUS.
Comunicação	A reforma depende de mudança cultural. Conecta com comunicação em saúde, jornalismo científico e advocacy.



Para o seu currículo

Identificar essas conexões é um diferencial acadêmico. Ao escrever um TCC ou um artigo, mostrar que você enxerga o tema em sua complexidade interdisciplinar — e não só na sua área específica — geralmente impressiona bancas e revisores.

Destaques

As frases mais marcantes da palestra, com comentários sobre por que importam.

 **"Não haverá mudança substancial na sobrevivência e experiência positiva no parto e nascimento sem a mudança do modelo obstétrico, com condução do processo assistencial pela enfermagem obstétrica e pelas obstetrizes."**

Por que importa:

Esta é a tese central da palestra. A palestrante a atribui à OMS — ou seja, não é uma posição corporativa de uma associação, é a recomendação técnica oficial do principal organismo internacional de saúde.

 **"A Rede Cegonha só avançou porque foi abraçada pelas enfermeiras obstétricas e pelas obstetrizes."**

Por que importa:

Mostra que mesmo políticas estatais bem-intencionadas dependem da apropriação ativa pelos profissionais da ponta. Sem mobilização da categoria, programas se transformam em letras frias.

 **"Um aumento modesto de 10% pode evitar 23% de mortes maternas e neonatais e 14% de natimortos ao ano."**

Por que importa:

É o dado mais poderoso da palestra. Mostra que não é preciso uma revolução de escala — basta uma mudança modesta na cobertura de intervenções por enfermeiras obstétricas, com autonomia profissional, para gerar impacto significativo. É um argumento técnico forte para vencer resistências.

 **"Investir no acesso universal ao cuidado obstétrico de qualidade realizado por enfermeiras obstétricas e obstetrizes pode, até 2035, salvar 4,3**

milhões de vidas todos os anos no mundo."

Por que importa:

Eleva a discussão para escala global. A Reforma Obstétrica brasileira é parte de um movimento mundial coordenado pela OMS, UNFPA e ICM (International Confederation of Midwives).

"Não tem rede cegonha que dê conta, não tem rede alyne que dê conta, se de fato a gente não mexer naquilo que é mais importante."

Por que importa:

É o momento mais contundente da palestra. Em uma única frase, a palestrante sintetiza a frustração com políticas que não tocam no cerne do problema. É também um chamado à ação para a categoria — e para todos os estudantes que vão ingressar na área nos próximos anos.

Dados em destaque

Dado	Contexto
~59%	Taxa de cesarianas no Brasil (vice-campeão mundial)
85%	Partos classificados como de risco habitual segundo a OMS
74%	Mulheres negras com gestações não planejadas
~2%	Uso de métodos contraceptivos de longa duração no Brasil
8%	Adequação dos cuidados pré-natais em mulheres negras
10%	Aumento modesto na cobertura por enfermeiras obstétricas que evitaria 23% das mortes
4,3 milhões	Vidas que poderiam ser salvas mundialmente até 2035 com cuidado liderado por enfermeiras obstétricas

Recapitulação Visual

Antes de fechar o Livebook, vamos consolidar tudo que vimos num mapa mental. Use esta seção como ferramenta de revisão.

O Núcleo da Reforma Obstétrica

PROBLEMA: Modelo brasileiro hospitalocêntrico e médico-centrado, com cesarianas em excesso, mortalidade materna alta e desigualdade racial.

CAUSA-RAIZ: Lógica de coordenação do cuidado, que mantém médicos no centro de TODOS os partos, inclusive os fisiológicos.

PROPOSTA: Liderança da enfermagem obstétrica e das obstetrizes nos partos de risco habitual, com colaboração interdisciplinar.

BASE TÉCNICA: Modelo de Transição Obstétrica da OMS (2024), com cinco modelos internacionais de inspiração.

IMPACTO ESPERADO: Redução de mortes maternas e neonatais; redução de cesarianas desnecessárias; melhor experiência de parto; equidade racial.

COMO ACONTECE: Articulação política (manifestos, audiências), formação profissional (750 novas enfermeiras obstétricas), regulação (COFEN), mobilização da categoria (ABENFO).

Resumo em uma frase

A Reforma Obstétrica brasileira propõe que enfermeiras obstétricas e obstetrizes assumam a liderança do cuidado nos 85% de partos de risco habitual, com colaboração de outros profissionais — porque, sem essa mudança estrutural, nenhuma política de saúde materna

conseguirá reduzir significativamente os índices de mortalidade e violência obstétrica no país.

Conclusões

Lições Aprendidas

- Mudanças de programa não são suficientes — sem mudar quem coordena o cuidado, indicadores não se movem.
- A Reforma Obstétrica é tecnicamente sustentada pela OMS, UNFPA, ICM e por evidências científicas robustas.
- A desigualdade racial está estruturalmente presente nos indicadores brasileiros de saúde materna.
- A categoria profissional precisa estar mobilizada — políticas só avançam quando são abraçadas pela ponta.
- Existem múltiplos modelos viáveis. O Brasil precisará adaptar regionalmente.

Próximos Passos (para você)

- Assinar o Manifesto pela Reforma Obstétrica (busque pelo QR Code da ABENFO ou pela Rede Feminista de Saúde).
- Acompanhar as redes sociais da ABENFO Nacional e da seccional do seu estado.
- Em estágios e atividades práticas, observar criticamente: as boas práticas estão sendo seguidas? A mulher é consultada nas decisões?
- Considerar a especialização em Enfermagem Obstétrica como caminho profissional, se você for da enfermagem.
- Levar o tema para grupos de estudo, ligas acadêmicas, entidades estudantis.

Recursos Mencionados

- Manifesto pela Reforma Obstétrica (ABENFO + Rede Feminista de Saúde + ReUna + outras).
- Documento da OMS — Modelo de Transição Obstétrica (2024).
- Pesquisa "Nascer no Brasil" (Fiocruz, 2014).
- Hospital Sofia Feldman (Belo Horizonte) — referência nacional em parto humanizado.
- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM, 2004).
- Rede Cegonha (2011) e Rede Alyne (2024).
- ICM — International Confederation of Midwives.

Para a sua próxima aula sobre o tema

Preste atenção em três pontos: (1) como sua professora ou professor explica o papel das enfermeiras obstétricas — há reconhecimento da liderança? (2) Os dados de mortalidade materna e racial são apresentados? (3) Há discussão sobre boas práticas no parto? Se algum desses pontos faltar, considere fazer perguntas — você vai estar à frente da turma.

Para o seu TCC ou trabalho

Este tema dá um excelente TCC. Algumas linhas possíveis:

- Análise comparativa: Rede Cegonha vs. Rede Alyne — o que mudou e o que não mudou.
- Estudo de caso: implementação de um Centro de Parto Normal em sua região.
- Revisão integrativa: o impacto da liderança da enfermagem obstétrica em indicadores de saúde materna.
- Pesquisa qualitativa: percepção de gestantes sobre a presença/ausência de enfermeiras obstétricas no pré-natal.
- Análise de política pública: o que a Lei do Acompanhante (Lei 11.108/2005) mudou na prática.

Trilha de Aprofundamento

Para começar (3 leituras introdutórias)

- Documento "Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento" — Ministério da Saúde / Fiocruz.
- Cartilha "Você sabe o que é parto humanizado?" — Defensoria Pública / Ministério Público.
- Vídeo-aulas da plataforma TelessaúdeRS (UFRGS) sobre saúde materno-infantil.

Para aprofundar (3 leituras intermediárias)

- Pesquisa "Nascer no Brasil" — Fiocruz, com leitura dos relatórios temáticos.
- Livro "Parto Vertical" — Vania Sorgatto Collaço (UFSC).
- Documento da OMS de 2024 sobre o Modelo de Transição Obstétrica (executive summary).

Para virar referência (3 obras canônicas)

- "Mulher gestante: princípios para o cuidado obstétrico" — Maria Helena Bastos.
- Boletins ABENFO — disponíveis no site oficial, com acúmulo técnico-científico da categoria.

- Lancet Series on Midwifery (2014) — série da revista The Lancet sobre o impacto global das parteiras.